

tamos de una gran cantidad de parásitos que circundan por nuestra vida cotidiana, presentes incluso en nuestros alimentos.

Hay que tener claro que el dióxido de cloro es muy eficaz, pero evidentemente no es un cura-todo, aunque puede eliminar bacterias, como la ‘pseudomona aeruginosa’ en una placa Petri, no pasa lo mismo en el cuerpo, donde es difícil de controlarla. También hay otros, como por ejemplo la microaerofilia como spirochaete que causa ‘borreliosis’ y que puede estar en tejidos profundos, y por el momento es muy difícil de eliminar, incluso con dióxido de cloro. Pero hay muchos casos de éxito, frente a otros pocos que no lo tuvieron. De igual manera el CD y el CDS aunque eliminan gran parte de las toxinas, no pueden matar las lombrices de gran tamaño, por lo que se deben acompañar de un protocolo de desparasitación, y más en casos de personas que manipulen animales y personas con mascotas que no se hayan desparasitado hace más de un año. Hay que tener en cuenta que la muerte de los parásitos puede generar a su vez más toxinas para el organismo, como por ejemplo el amonio liberado por estos parásitos, por lo que la persona puede tener crisis curativas con reacciones adversas como: mareos, vómitos, diarrea y malestar general, que son un indicativo de su presencia.

Así pues, **cualquier persona a quien el dióxido de cloro haya funcionado muy bien durante los primeros meses pero luego haya vuelto a recaer, debe primero hacer una desparasitación**, y luego hacer otro tratamiento con dióxido de cloro, que permita la desintoxicación final de los desechos parasitarios en el cuerpo. El dióxido de cloro mata a los patógenos y oxida los metales pesados, haciendo posible su eliminación de nuestro cuerpo, y a su vez, destruye la mayor parte de los venenos.

El protocolo de mantenimiento es el protocolo A. Este fácil y simple protocolo para mantener el sistema inmune, trabaja al máximo de eficiencia, ya que reduce la aparición de cualquier gripe o resfriado y ayuda a prevenir el cáncer y otras muchas enfermedades mortales causadas por demasiada acidez en el cuerpo y falta de oxígeno celular. Una pequeña cantidad de CD/CDS tomada frecuentemente parece prevenir la formación y el desarrollo del cáncer. Si tomando este protocolo preventivo o de mantenimiento, se le manifiestan síntomas de alguna otra enfermedad, debe cambiar al protocolo adecuado, hasta que los síntomas hayan desaparecido.

Algunas personas no son consecuentes ni disciplinadas en el uso del dióxido de cloro, siendo muchas veces esta la causa verdadera de que el tratamiento no funcione, o no dé los resultados esperados. La experiencia ha demostrado que las personas disciplinadas con las tomas, han tenido grandes éxitos demostrables para combatir las enfermedades crónicas, graves o incluso terminales, pudiendo confirmar la frase: “Incurable era ayer”:)

Capítulo 4

En este capítulo se describen las enfermedades en su mayoría consideradas incurables o de difícil curación, con los tratamientos y los resultados obtenidos avalados en cada caso con un testimonio real.

Aunque científicamente un testimonio no tiene validez, para todos aquellos que sufren la enfermedad SI VALE.

Abceso	Cáncer de pulmón
Acné	Cáncer de riñón
Afta	Cáncer tiroideo
Alergia	Cáncer uterino
Alzheimer	Cáncer de vejiga
Amigdalitis	Candidiasis
Ansiedad	Caspa
Apendicitis	Chagas
Arterioesclerosis / Arteromatosis	Chikungunya
Artritis reumatoide	Ciática
Artrosis	Cirrosis hepática
Asma	Cistitis
Autismo	Colitis ulcerosa
Bronquitis	Colesterol alto
Brucelosis	Conjuntivitis
Bursitis	Demencia
Cálculo Renal	Dengue
Calvicie	Depresión
Cáncer Colorrectal	Dermatitis atópica
Cáncer de esófago	Diabetes
Cáncer de estómago o gástrico	Diarrea
Cáncer de hígado	Disfunción eréctil
Cáncer de lengua	Diverticulitis
Cáncer de mama	Dolor de cabeza
Cáncer óseo	Ébola
Cáncer de ovario	Enfermedad Autoinmune
Cáncer de páncreas	Enfermedad de Crohn
Cáncer de próstata	Enfermedad de Lyme

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica - EPOC	Migraña (Dolor de cabeza)
Erupciones en la piel	Mononucleosis infecciosa (Virus Epstein-Barr)
Escherichia coli	Nefritis (Glomerulonefritis Posestreptocócica)
Esclerosis lateral amiotrófica - ELA	Neumonía (Pulmonía)
Esclerosis múltiple	Osteomielitis
Esquizofrenia	Osteoporosis
Estomatitis vesicular	Otitis
Fibromialgia	Papiloma virus (ver VPH)
Fiebre tifoidea	Periodontitis (Ver Gingivitis)
Fístula anal	Picaduras
Fractura	Pie de atleta
Gastritis	Prostatitis
Gastroenteritis	Psoriasis
Gingivitis (Ver Periodontitis)	Pulmonía (ver Neumonía)
Glomerulonefritis posestreptocócica (Síndrome Nefrítico)	Quemadura
Gonorrea	Quiste
Gota	Reflujo
Gripe	Resfriado Común
Hepatitis	Rinitis alérgica
Herida	Sarcoidosis
Hernia	Sarm (Staphylococcus aureus)
Herpes (zoster, genital)	Sama
Hipertensión arterial	Síndrome Sjögren
Hipotiroidismo	Sinusitis
Hongos-micosis	Staphylococcus (MRSA)
Infección	Trastorno bipolar
Insuficiencia cardíaca	Trombosis venosa
Insuficiencia renal (Nefritis, Glomerulonefritis Posestreptocócica)	Tuberculosis
Isquemia reperusión renal	Tumor
Leishmaniasis cutánea - UTA	Úlceras Pépticas (Helicobacter)
Leucemia	Úlceras Vasculares
Lou Gherig (ver Esclerosis Lateral Amiotrófica - ELA)	Uveítis
Linfoma	Vaginosis bacteriana
Liquen escleroso atrófico	Varices
Lupus	Verruga
Malaria	VIH
Meningitis viral	Viras de Epstein-Barr (Citomegalovirus)
Metales pesados	Vitíligo
	VPH (Virus del papiloma humano)

Absceso

1. Un absceso es...

Un absceso se presenta cuando una infección provoca la acumulación de pus en la piel de cualquier parte del cuerpo. Puede ser externo y visible sobre la piel, o bien interno. Cuando se encuentra supurado se denomina apostema. Se puede presentar después de una infección bacteriana, una herida, forúnculos o una foliculitis.

0 Síntomas:

Los síntomas pueden incluir:

Fiebre o escalofrío, en algunos casos

Hinchazón local alrededor del punto afectado

Endurecimiento del tejido de la piel

Lesión cutánea que puede ser una úlcera abierta o cerrada, o un nódulo abultado

Enrojecimiento, sensibilidad y calor en la zona

Salida de líquido

2, Testimonio:

Este es un testimonio personal.

Hace unos meses, se me cayó una platificación de un diente.

Estuve casi una semana sin ir al dentista, solamente lavándome bien los dientes varias veces al día, pero me molestaba mucho cada vez que comía.

Cuando por fin fui al dentista, el dolor ya era insoportable, y me llegaba hasta la mandíbula. Mi dentista me removió lo que quedaba de platificación, y me arregló el diente con resina (pasta), que fue lo que le pedí, para eliminar todo tipo de metal de la boca. En fin, él me dijo que volviera en una semana para ver como seguía el progreso.

A la siguiente semana regrese, ya que me estaba quejando de que todavía me dolía cuando comía, especialmente carnes (fibra), que se me quedaba entre la encía del diente y me molestaba.

El me dijo que no había más opción que hacerme un 'root canal' (endodoncia), o quitar el diente!

Le di una mirada y le dije: ' Dame una semana, y te cuento '

Llegué a mi casa y empecé a hacer lo siguiente:

- 1) En un vaso pequeño de cristal, puse íml (ice) de CDS (Chlorine Dioxide Solution). Esto equivale a aproximadamente 4 gotas de MMS activadas con 4 gotas